EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 76795
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 05-01-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: AMELIA DEL CARMEN VENEGAS ORTIZ			RUN	: 9.327.609-4
F.Nac	: 05-01-1955	Edad	: 69 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: LONQUEN PANGUILEMO SAN NICOLA			Comuna	: NINHUE
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-12-13	Fecha Egreso	: 05-01-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A09.9-GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORTIGEN NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SHOCK SEPTICO PERITONITIS POR COLECISTITIS GANGRENOSA OPEPRADA
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA - TEP LOBAR - NEUMONIA EN TTO
IAM RECIENTE
ALZHEIMER - HTA - DM-2 - IC
EAOC - ISQUEMIA CRITICA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I82-OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. K80.0-CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. K65-PERITONITIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE INGRASADA POR URGENCIAS EL 11-12-23 POR SHOCK SEPTICO DE ORIGEN BILIAR (PERITONITIS POR COLECISTITIS GANGRENOSA) Y TVP FEMORAL DERECHA, SE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE EN ESPERA DE COLECISTECTOMIA REALIZADA EL 17-12-23, POSTOPERADO EN UTI

SE SOLICITA EVALUACION POR DESATURACION REPENTINA HASTA 68% Y COMPROMISO DE CONCIENCIA. RESPONDE A O2 POR NARICERA 2 LITROS. SE SOLICITA TAC DE CEREBRO Y ANGIOTAC DE TORAX (ANTECEDENTE DE TEP LOBAR EN TTO CON DABIGRATAN) NEUMONIA EN 12° DIA DE TTO CON TAZONAM.
AL EXAMEN
PACIENTE EN MUY MALAS CONDICIONES, CON DETERIORO ABRUPTO EN LAS ULTIMAS HORAS, CON COMPROMISO DE CONCIENCIA, GLASGOW 5 (SOLO RESPUESTA MOTORA AL DOLOR Y OCULAR AL DOLOR, NO EMITE SONIDOS)
CON RFM (+) REFLEJO CORNEAL (+), RIGIDEZ NUCAL, MP (+) MUY DISMINUIDOS EN AMBAS BASES CON ESTERTORES BILATERALES. USO DE MUSCULATURA ACCESORIA.
TAC DE CEREBRO SIN SIGNOS DE ACV, SIN SIGNOS DE TEP AGUDO HASTA NIVEL SEGMENTARIO.
NEUMONIA ASPIRATIVA BIBASAL.
SE CONVERSA GRAVEDAD DE CONDICION DE PACIENTE CON ESPOSO Y 3 HIJAS Y EN CONJUNTO SE DECIDE LIMITACION DE ESFUERZO TERAPEUTICO Y ORDEN DE NO REANIMACION.

PACIENTE SE HA MANTENIDO DESORIENTADA, CON RESPUESTA MOTORA Y OCULAR AL DOLOR, NO EMITE SONIDOS.
CON ALTOS REQUERIMIENTOS DE O2 SUPLEMENTARIOS CON MAF
AFEBRIL, HEMODINAMIA ESTABLE
DIURESIS+, DEPOSICIONES-

SE CONVERSA CON FAMILIA QUIENES EXPRESAN SU DESEO PARA QUE CUIDADOS DE FIN DE VIDA Y FALLECIMIENTO SEA EN SU DOMICILIO.

PLAN DE MANEJO:

MANEJO PROPORCIONAL
CURACIONES POR HODOM
LIMITACION ESFUERZO TERAPEUTICO
ORDEN DE NO REANIMACION
CONSULTAR EN URGENCIA SOS

INDICACIONES AL ALTA

1. ANALGESIA
2. O2 SUPLEMENTARIO
3. MORFINA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 AMP. EN 500 ML A 20 ML/H
4. PARACETAMOL 1 G/100 ML MATRAZ UNIDAD 1 matraz cada 12 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA
5. CURACIONES POR HODOM
6. CUIDADOS DE FIN DE VIDA
7. CONSULTAR EN URGENCIA SOS

SOFÍA MACARENA SPANO TORRES
MEDICO TRATANTE
17043328-9

JEFE SERVICIO